リハ医療デイリー

REHABILITATION & MEDICINE DAILY

2026年10月30日（金）

第49号　朝刊

きょうの紙面　▸脳卒中 × 薬物療法　▸評価 × ICF　▸嚥下 × パーキンソン病　▸短信 8本

■ 脳卒中 × 薬物療法

脳卒中後の運動回復 レボドパの効果、根拠得られず

12試験・1,860人を統合　低バイアスの2試験では差ほぼゼロ

脳卒中後の運動機能を高めるため、レボドパやドパミン作動薬をリハと併用すると効果があるか。バーゼル大学病院などのCochraneレビューは、2025年11月までを検索し、無作為化比較試験12件・1,860人をまとめた。11件がレボドパ、1件がロピニロールだった。

運動機能を連続変数で統合できた6試験・1,258人では、標準化平均差（SMD）は1.42、95%信頼区間は−0.20～3.05で、明確な差は確認できなかった。研究間のばらつきはI^2=99%と大きく、根拠の確実性は非常に低い。バイアスのリスクが全領域で低い2試験・1,025人に絞ると、SMDは0.02（−0.10～0.14）、I^2=0%だった。

重篤な有害事象は6試験・1,281人でRR 1.03（0.83～1.27）と差は見られなかった。ただし「効かないと証明した」のではなく、「効くという根拠が得られていない」と読むべき結果だ。著者は今後の研究で評価が変わる可能性も示す。薬の追加効果を調べた研究で、治療の優先順位を決める結果ではない。



薬物療法の追加効果と、リハそのものの質を分けて考える。

出典 Cochrane ↗

数字で見る

12試験	1,860人	0.02SMD
無作為化比較試験	レビューの総対象	低バイアス2試験

■ 評価 × ICF

ClinFITの意味ある変化 約57点、なお探索的

豪州の入院リハ患者257人を対象に、ICFに基づく尺度ClinFITの最小の意味ある変化（MIC）を検討した。得点は入院時167.0から退院時97.7へ低下し、低下が改善を表す。得点変化の相関はEQ-5D-5Lで−0.68、FIMでは−0.31だった。

EQ-5D-5Lを基準にしたMICは約57点の低下。ただし信頼区間は広く、ROC解析では探索的に50～70点の範囲が示された。単一施設の結果で、FIMを置き換えられるとは言えない。尺度が生活の何を捉えるかを確認する材料になる。



出典 Disabil Rehabil ↗

■ 嚥下 × パーキンソン病

嚥下の自覚症状を追跡 質問票と造影所見に関連

パーキンソン病103人の嚥下質問票SDQと嚥下造影のVDSを比較した。SDQの総得点はVDSと関連（β=1.18）し、口腔より咽頭領域で関連が強かった。24人・39組の追跡データでも、SDQの変化とVDSの変化に関連があった。

検査を紹介された患者の後ろ向き研究で、一般の患者全体への適用には注意が要る。著者は質問票が機器による評価を置き換えるものではないと明記する。同じ質問を継続して聞き、追加検査が必要かを考える手がかりとして使いたい。



出典 Mov Disord Clin Pract ↗

短信

〈脳卒中〉 **足底の識別学習を追加**

34人の無作為化試験。足底の硬さ識別を加え、転倒リスクとFIMに改善を報告。小規模な単一試験で追試が必要。

出典 PubMed ↗

〈心リハ〉 **自己管理の知識を国際比較**

11か国17施設、4,309人の観察研究。知識の追跡データは3,359人。知識には地域や経済状況による違いも。

出典 PubMed ↗

〈嚥下〉 **予防的胃瘻の優位性示せず**

頭頸部がんの無作為化試験57人。予防的と必要時の胃瘻で嚥下関連QOLに差なし。早期終了で解釈には限界。

出典 PubMed ↗

〈生活〉 **活動回避と恐怖の関連**

パーキンソン病の横断研究で、恐怖に基づく活動回避の関連因子を検討。因果関係や介入の効果を示した結果ではない。

出典 JNPT ↗

〈筋機能〉 **病期別サルコペニアを調査**

パーキンソン病の病期ごとに、ICFに基づく枠組みでサルコペニアを検討。横断調査で、病状変化の予測とは異なる。

出典 PubMed ↗

〈退院支援〉 **米国の急性期後ケアを整理**

米国の急性期後ケアの判定を文献レビューで整理。制度や受け皿が異なるため、日本の回復期病棟への適用は別に検討。

出典 PubMed ↗

〈自己管理〉 **導入を阻む要因を整理**

脳卒中後の自己管理支援について24研究を検討。個別化や社会的支援、人員の課題を整理。異質性が高く優先順位は未定。　出典 PubMed ↗

〈病床連携〉 **低コスト策導入後、紹介率上昇**

豪州の急性期脳卒中・神経内科で代替病床への紹介率が5.6%から9.6%へ。対照群のない前後比較で効果は慎重に。

出典 PubMed ↗